

TURP — Трансуретральная резекция простаты

Информация для пациента · Стандартная операция при увеличенной простате

WARWIKI

TURP — распространённая, хорошо изученная операция при доброкачественной гиперплазии простаты (BPH), блокирующей отток мочи. Через уретру вводится инструмент — **без наружного разреза** — и хирург удаляет внутреннюю ткань простаты, которая сдавливает мочеиспускательный канал. Результат — выраженное и стойкое улучшение струи мочи, подтверждённое десятилетиями практики.

Об этой операции

Через уретру вводится тонкий инструмент — **резектоскоп**. С помощью небольшой электрической петли хирург удаляет мешающую внутреннюю ткань простаты по частям, расширяя канал. Наружная часть простаты остаётся на месте. После операции устанавливается катетер на время заживления.

Это безопасно?

TURP — одна из наиболее изученных урологических операций с высокой эффективностью. Как и любое хирургическое вмешательство, она имеет риски: кровотечение, инфекция, временное раздражение, а также ряд ожидаемых долгосрочных изменений (см. ниже). Операция наиболее подходит при простате **среднего размера**; при очень крупной железе предпочтительнее HoLEP, Aquablation или открытая простатэктомия.

ТЕРМИНЫ

TURP

Трансуретральная резекция простаты — эндоскопическая операция при BPH.

BPH

Доброкачественная (не раковая) гиперплазия простаты.

Резектоскоп

Инструмент со световодом и петлей для удаления ткани простаты.

Ретроградная эякуляция

Семя попадает обратно в мочевой пузырь — частое, безвредное последствие.

Катетер

Трубка для дренирования мочевого пузыря в течение 1–3 дней после операции.

Ирригация мочевого пузыря

Промывание через катетер для удаления крови в первые сутки.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ? У большинства мужчин значительно усиливается струя мочи. Наиболее частое стойкое изменение — **ретроградная эякуляция**: семя уходит обратно в мочевой пузырь, оргазм ощущается нормально, но выделяется мало жидкости или она отсутствует. Это безвредно (хотя влияет на фертильность). Серьёзные нарушения эрекции или удержания мочи встречаются редко.

Как подготовиться

- Операция выполняется под **спинальной или общей анестезией** — соблюдайте предписания по голоданию и приёму лекарств (разжижители крови отменяются по указанию врача).
- **Анализ мочи** для исключения инфекции.
- Организуйте транспорт домой; рассчитывайте на катетер в течение нескольких дней.

Что происходит и после

- 1 Вы спите или обезболены; вводятся антибиотики.
- 2 Мешающая ткань простаты удаляется через инструмент.
- 3 Устанавливается катетер; в первые сутки иногда промывается мочевой пузырь.
- 4 Обычно одна ночь в больнице; катетер удаляется через **1–3 дня**.

Ожидайте **розоватую мочу** и лёгкое жжение/позывы в течение нескольких недель; пейте больше жидкости, избегайте натуживания и тяжёлой нагрузки.

Обратитесь к врачу, если у вас:

- После удаления катетера **нет мочеиспускания**
- **Сильное кровотечение или сгустки**, затрудняющие отток
- Повышение температуры или озноб
- Усиливающееся кровотечение (небольшое кровотечение через 1–2 недели — норма: покой и жидкость)

ТРИ ВАЖНЫХ МОМЕНТА

1. TURP удаляет мешающую внутреннюю часть простаты через инструмент (без разреза) — проверенный, высокоэффективный стандарт при умеренном BPH.
2. Ожидайте усиления струи мочи; частое стойкое изменение — ретроградная эякуляция (безвредна).
3. Розоватая моча и раздражение проходят за несколько недель. Обратитесь к врачу при задержке мочи, сильном кровотечении или температуре.